

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 4 ИЮЛЯ 2023 ГОДА N 108

**[ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
РОЖДАЕМОСТИ НА ПЕРИОД 2023 - 2025 ГОДОВ]**

(с изменениями на 15 декабря 2023 года)

(в ред. [Постановления Правительства Республики Ингушетия от 15.12.2023 N 175](#))

Во исполнение [Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации"](#), с целью стабилизации демографической ситуации, поддержки материнства и детства на территории Республики Ингушетия, в соответствии с пунктом 7 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 апреля 2023 года N ПР-826 по итогам совещания о мерах по повышению рождаемости в Российской Федерации Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Республики Ингушетия по повышению рождаемости на период 2023 - 2025 годов (далее - программа).

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Ингушетия, ответственным за реализацию программы:

а) обеспечить выполнение мероприятий программы;

б) ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения мероприятий программы в Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия.

3. Контроль за исполнением программы возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия, курирующего социальные вопросы.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В.В.СЛАСТЕНИН

**Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от 4 июля 2023 г. N 108**

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ НА
ПЕРИОД 2023 - 2025 ГОДОВ (ДАЛЕЕ - РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)**

(в ред. [Постановления Правительства Республики Ингушетия от 15.12.2023 N 175](#))

**ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Сроки реализации региональной программы	2023 - 2025 годы
Ответственный исполнитель региональной программы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия
Участники региональной программы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия; Министерство образования и науки Республики Ингушетия; Отделение Фонда медицинского страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия; Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия
Цель региональной программы	Выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений, а также определение целевых значений показателей рождаемости в Республике Ингушетия
Задачи региональной программы	1. Комплексный анализ демографической ситуации в регионе на основе оценки демографического потенциала. 2. Определение перечня факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений в регионе. 3. Определение и обоснование целевых значений общего числа рождений в регионе на период 2023 - 2025 годов. 4. Формирование комплекса региональных мер по повышению рождаемости с учетом анализа сложившейся демографической ситуации и действующего пакета мер
Объемы финансового обеспечения региональной программы	Объем региональной программы - 5 400 000,0 рублей, в том числе по годам: 2023 год - 1 800 000,0 рублей; 2024 год - 1 800 000,0 рублей; 2025 год - 1 800 000,0 рублей

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональная программа подготовлена в целях улучшения демографической ситуации на территории Республики Ингушетия в соответствии с пунктом 7 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 апреля 2023 года N Пр-826 о мерах по повышению рождаемости в Российской Федерации, согласно [Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2023 года N 436 "Об утверждении Методических рекомендаций по оценке демографического потенциала субъекта Российской Федерации и разработке региональных программ по повышению рождаемости"](#). Для анализа оценки демографического потенциала Республики Ингушетия использована официальная статистическая информация Росстата, Кавказстата, федеральных органов государственной власти, отчетные данные органов исполнительной власти Республики Ингушетия.

В Республике Ингушетия сохранены важные и позитивные традиции, влияющие на здоровье нации. Многодетные семьи являются общепринятой ценностью, а религиозные и общественные мнения признают аборт как убийство ребенка. Республика Ингушетия занимает третье место по общему коэффициенту рождаемости, уступая только Чеченской Республике и Республике Тыва. Отмечается тенденция увеличения показателей рождаемости и естественного прироста населения.

Снижение материнской, младенческой и детской смертности в регионе представляет большую сложность в силу наличия многочисленных факторов, в основном трудно управляемых, которые влияют на эти показатели. Показатель материнской смертности зависит от социально-экономического состояния, географических особенностей, развития

медицинской помощи, культурного и образовательного уровня населения.

На уровень младенческой смертности влияет целый ряд факторов, требующих междисциплинарного подхода. Прежде всего, это состояние материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, которые до настоящего времени не полностью обеспечены койками реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, располагающих современным высокотехнологичным оборудованием. Отсутствует перинатальный центр, в котором оказывается медицинская помощь наиболее тяжелому контингенту беременных, рожениц, родильниц и новорожденных детей.

Наличие высококвалифицированных специалистов в учреждениях родовспоможения и детства играет огромную роль в снижении показателя младенческой смертности. В Республике Ингушетия имеется кадровый дефицит как неонатологов, так и медицинских сестер.

Существенное влияние на качество оказания медицинской помощи новорожденным, родившимся с патологией, и результат их лечения оказывает уровень финансирования медицинских организаций.

Другие факторы также оказывают существенное влияние на уровень материнской и младенческой смертности - качество дорожного сообщения, достаточная доступность автомобильного и авиационного санитарного транспорта, здоровый образ жизни населения.

Снижение младенческой и детской смертности от травм, насильственных действий, пренебрежения родителями из социально неблагополучных семей здоровьем и благополучием своих детей является зоной ответственности не только и не столько медицинских работников, сколько органов социальной защиты населения, МВД, МЧС и др.

Важным направлением снижения смертности детского населения является улучшение помощи новорожденным, чрезвычайно значимым аспектом которой является строительство перинатального центра - высокотехнологичного центра, который позволит обеспечивать эффективную помощь при самой тяжелой патологии, развивать инновационные методы лечения.

Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и наследственных болезней является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика, включающая скрининг на сывороточные маркеры матери, программу индивидуального риска, методы диагностики. Эффективность пренатальной диагностики может быть достигнута только массовым обследованием беременных женщин в установленные сроки.

Вместе с тем не теряет своей актуальности раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний сразу после рождения ребенка.

Раннее выявление заболеваний и патологических состояний у детей всех возрастных групп диктует необходимость внедрения современных лечебных технологий в деятельность медицинских организаций педиатрического профиля.

Одним из важных направлений современной медицины, позволяющим оказывать своевременную медицинскую помощь детям в первые часы и месяцы жизни, является неонатальная хирургия. Оказание такой помощи возможно только в условиях современных медицинских организаций акушерского и педиатрического профиля, обладающих соответствующей материально-технической базой, высококвалифицированными кадрами, владеющими инновационными технологиями диагностики и лечения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью региональной программы является выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в положительной динамике демографических показателей и стабилизации общего социального климата в республике.

Задачи региональной программы заключаются в следующем:

1. Комплексный анализ демографической ситуации в регионе на основе оценки демографического потенциала.
2. Определение перечня факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений в регионе.
3. Определение и обоснование целевых значений общего числа рождений в регионе на период 2023 - 2025 годов.
4. Формирование комплекса региональных мер повышения рождаемости с учетом анализа сложившейся демографической ситуации и действующего пакета мер.

III. ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

1. ЧИСЛЕННОСТЬ, СТРУКТУРА, ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

По численности населения Республика Ингушетия относится к одному из самых малочисленных регионов России: по состоянию на 1 января 2022 года число жителей составляло 524 058 человек. Плотность населения составляет 166,21 человека на один квадратный километр. Доля городского населения в общей численности населения - 55,8%, сельского - 44,2%. В составе Республики Ингушетия выделяются следующие крупные города - Назрань (125 297 чел.), Сунжа (67 142 чел.), Карабулак (44 731).

Таблица 1. Численность населения Республики Ингушетия по состоянию на 1 января 2022 г. в разрезе населенных пунктов

Наименование	По состоянию на 01.01.22	Наименование	По состоянию на 01.01.22
Республика Ингушетия	524058	село Али-Юрт	6948
Джейрахский район	3553	село Гази-Юрт	2048
село Гули	311	село Долаково	7527
село Лейми	3	село Гейрбек-Юрт	259
село Пялинг	2	село Кантышево	18834

село Эгикхал	3	село Сурхахи	13295
село Таргим	6	село Экажево	19876
село Джейрах	2167	село Яндаре	9537
село Арамхи	175	Сунженский район	61686
село Тамариани	9	село Алкун	1206
село Ляжги	355	село Алхасты	4714
село Бейни	109	село Аршты	1505
село Ольгети	409	село Галашки	7588
село Шоани	4	село Даттых	290
Малгобекский район	60231	село Мужичи	2321
село Аки-Юрт	1655	станция Нестеровская	24022
село Средние Ачалуки	3849	станция Троицкая	18441
село Вежари	1040	село Чемульга	1141
Верхние Ачалуки	8806	село Берд-Юрт	458
станция Вознесенская	1398	г. Сунжа	67142
село Южное	1373	г. Магас	15279
село Инарки	7259	г. Малгобек	39794
село Зязиков-Юрт	5533	г. Карабулак	44731
село Нижние Ачалуки	5739	г. Назрань	125297
село Новый Редант	4676	Гамурзиевский адм. округ	12822
село Пседах	6114	Насыр-Кортский адм. окр.	25820
село Сагопши	12789	Центральный адм. округ	77883
Назрановский район	106345	Альтиеvский адм. округ	8772
село Плиево	16370	городское население	292243
село Барсуки	11651	сельское население	231815

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Как уже отмечалось ранее, Ингушетия является регионом с высокой долей сельского населения. Вместе с тем удельный вес сельского населения в общей численности составил в 2022 году 44,2%, что на 14,5 процентных пункта ниже значения 2016 года. Это может быть связано с развитием городской инфраструктуры в регионе и незавершенным процессом урбанизации.

Как можно заметить, в 2018 году наблюдается выраженный поток миграции из сельской местности в городскую: численность сельского населения сократилась на 22%, в то время как численность городского населения возросла на 34,4% (в сравнении с 2016 годом).

Таблица 2. Динамика численности населения
Республики Ингушетия, 2016 - 2022

Год	Всего, человек	В том числе:		Удельный вес в общей численности, в %	
		городское население	сельское население	городского населения	сельского населения
2016	472 776	195 255	277 521	41,3	58,7
2017	480 474	200 835	279 639	41,8	58,2
2018	488 043	269 949	218 094	55,3	44,7
2019	497 393	275 891	221 502	55,5	44,5
2020	507 061	282 147	224 914	55,6	44,4
2021	515 564	287 222	228 342	55,7	44,3
2022	524 058	292 243	231 815	55,8	44,2

Половозрастная пирамида Республики Ингушетия соответствует прогрессивному типу и, в отличие от структуры населения Российской Федерации, характеризуется высокой долей детей и низкой долей лиц пожилого возраста. Это свидетельствует о высоком потенциале расширенного воспроизводства населения. В отличие от среднероссийских тенденций к сокращению численности населения, можно ожидать дальнейший естественный прирост населения, связанный с особенностями половозрастной структуры населения в Республике Ингушетия: молодые когорты мужчин и женщин (в возрасте до 30 лет) постепенно будут входить в активный репродуктивный возраст и полностью заменять выбывшее население. С учетом указанных тенденций в данный момент наблюдается благоприятное время для активизации мер по повышению рождаемости.

Рисунок 1. Половозрастная пирамида Республики Ингушетия,
2022 год*

* Рисунок 1 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

В Ингушетии рождается больше мальчиков, чем девочек. По состоянию на 1 января 2022 года на 100 девочек в среднем приходится 106 мальчиков, при этом дисбаланс в соотношении численности мальчиков и девочек при рождении снизился в сравнении с 2016 годом, в котором на 100 девочек приходилось 109 - 110 мальчиков. Это значимый факт, поскольку с учетом феномена гендерной сверхсмертности и особенностями асимметричной миграции в регион или из него могут наблюдаться существенные различия в распределении мужчин и женщин репродуктивного возраста.

Соотношение мужчин и женщин репродуктивного возраста (15 - 49 лет) в Республике Ингушетия свидетельствует о значительной диспропорции в пользу преобладания женщин. Наблюдается незначительное увеличение числа мужчин в расчете на 1 женщину: темп прироста составил 1,4% в 2022 году в сравнении с 2016 годом. На 2022 год в Российской Федерации на 1000 женщин репродуктивного возраста приходится в среднем 994 мужчины, в то время как соответствующий показатель в Республике Ингушетия составляет 803 мужчины.

Таблица 3. Динамика численности мужчин в возрасте 15 - 49 лет, приходящихся на одну женщину фертильного возраста (15 - 49 лет), на 1 января

Субъект	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Республика Ингушетия	0,791	0,793	0,793	0,795	0,797	0,800	0,803
Российская Федерация	0,986	0,987	0,989	0,990	0,992	0,992	0,994

Следует отметить, что до 8 лет в численности населения субъекта преобладают мужчины, после 9 лет - женщины. Эта особенность Республики Ингушетия существенно выделяет ее среди регионов России, где соотношение между полами выравнивается примерно в 35 лет и лишь затем идет в сторону преобладания женщин. Следует отметить, что существенная диспропорция в численности мужчин и женщин в репродуктивном возрасте может являться сдерживающим фактором повышения рождаемости в Ингушетии. Существенное преобладание женщин в общей численности населения Республики Ингушетия связано в том числе с феноменом гендерной сверхсмертности, а также различиями в структуре причин смерти и их "вклада" в ожидаемую продолжительность жизни.

Ингушетия стала единственным регионом, где снизилась ожидаемая продолжительность жизни (далее - ОПЖ) - в 2022 году снизилась по отношению к 2021 году. На 2022 год ОПЖ составляет 78,37 лет, что на 2,15 ниже соответствующего показателя за 2021 год. В разрезе по полу ожидаемая продолжительность жизни составляет (на 2022 год) 80,44 лет для женщин и 76,29 лет для мужчин. Несмотря на неблагоприятную тенденцию в виде сокращения ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году, Республика Ингушетия является регионом-лидером по данному показателю среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В 2022 году разница в ОПЖ между Республикой Ингушетия и Северо-Кавказским федеральным округом составила 2,53 года.

Таблица 4. Ожидаемая продолжительность жизни в регионах Северо-Кавказского федерального округа

Субъект	Число лет
Северо-Кавказский федеральный округ	75,84
Республика Дагестан	78,29
Республика Ингушетия	78,37
Кабардино-Балкарская Республика	75,56
Карачаево-Черкесская Республика	75,41
Республика Северная Осетия-Алания	74,72
Чеченская Республика	74,66
Ставропольский край	74,33

Существует множество факторов, объясняющих высокое значение ожидаемой продолжительности жизни, и одним из важнейших является снижение младенческой и детской смертности. Новорожденным в Ингушетии проводится расширенный неонатальный скрининг, который позволяет врачам выявлять патологии на самом раннем возрасте и вовремя начать лечение.

Важным фактором высокого значения ОПЖ является ведение жителями республики здорового образа жизни. Ингушетия традиционно является одним из некурящих регионов страны и возглавляет рейтинги регионов-лидеров, ведущих трезвый образ жизни. На продолжительность жизни в Ингушетии влияет не только медицина, но и экологическая обстановка. Отсутствие вредных для здоровья человека промышленных производств, чистый воздух и экологически чистые продукты питания, выращенные сельхозпредприятиями региона.

На снижение смертности жителей республики влияют различные программы развития здравоохранения - проводится оснащение больниц оборудованием по сердечно-сосудистому и онкологическому профилю, эти заболевания являются ведущими причинами смертности. В регионе ежемесячно проводится мониторинг основных демографических показателей, диспансеризация и профилактические осмотры населения (углубленная программа), диспансерное наблюдение за пациентами из группы ХНИЗ (хронические неинфекционные заболевания), реабилитация в амбулаторных и стационарных условиях лиц с заболеваниями, выявленными по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Благодаря федеральным программам и нацпроекту "Здравоохранение" обеспечено увеличение объемов высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи. В регионе практикуется проведение телемедицинских консультаций с федеральными дистанционными центрами. В Ингушетии реализуются мероприятия национального проекта "Демография" в части оказания медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста, которые также улучшают показатели продолжительности жизни. В республике функционирует гериатрический центр, в котором развернуто 15 коек, проводятся профилактические осмотры и диспансеризация лиц старшего возраста, осуществляется их диспансерное наблюдение. Госпитализируют пациентов гериатрического центра в Ингушетии вместе с ухаживающим родственником. В Ингушетии это направление в последние годы активно развивается.

Структура причин смертности населения Республики Ингушетия в последние годы значительно изменилась. В 2022 году число умерших на тысячу населения составило 3,4; за 2021 год - 3,9, младенческая смертность - 4,3, за предшествующий год - 5,2. В структуре смертности на первом месте находятся болезни системы кровообращения - 37%, на втором месте новообразования - 13,3%, на третьем месте - внешние причины - 6,7%. Негативной тенденцией региона является рост числа умерших в трудоспособных возрастах.

Вследствие превышения числа родившихся над числом умерших в Республике Ингушетия, в отличие от Российской Федерации, наблюдается положительный естественный прирост населения. Вместе с тем за период 2016 - 2022 годов наблюдается сокращение данного показателя на 9,2%. Данная тенденция актуализирует необходимость проектировки релевантных и эффективных мероприятий по повышению рождаемости в регионе.

Рисунок 2. Динамика естественного прироста населения,
Республика Ингушетия и Российская Федерация, 2016 - 2022*

* Рисунок 2 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Наряду с естественным приростом населения в Республике Ингушетия отмечается положительный миграционный прирост. Динамика миграционного прироста в расчете на 10 000 населения свидетельствует об устойчивом превышении числа прибывших над числом уехавших, причем данный показатель выше, чем по Российской Федерации. За январь - декабрь 2022 года число прибывших в Республику Ингушетия составило 8,2 тыс. человек, из них 60,7% по межрегиональной миграции, 6,3% приходится на международные потоки. Из Республики выбыло 6,6 тыс. человек, в том числе 54,6% - в другие субъекты России, за пределы страны - 4,6%. Внутрирегиональные перемещения составили 2,7 тыс. человек. Наибольшее число прибывших и выбывших наблюдалось в городах Назрань и Магас. Доля населения трудоспособного возраста в структуре миграционного прироста наибольшая и составляет 81,5%. Это косвенно свидетельствует о том, что диспропорция в соотношении численности мужчин и женщин в большей степени объясняется гендерными различиями в глубине смертности и ее структуре по причинам смерти.

Рисунок 3. Динамика миграционного прироста.
Республика Ингушетия и Российская Федерация, 2016 - 2022*

* Рисунок 3 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Таким образом, можно сделать следующие выводы из анализа динамики численности населения, его структуры, а также естественного и миграционного движения населения. В Республике Ингушетия сложилась благоприятная ситуация роста численности населения как за счет естественной компоненты - превышения числа рожденных над числом умерших, так и за счет миграционного прироста. В регионе наблюдается реструктуризация населения по месту проживания. Незавершенный процесс урбанизации объясняет растущую долю горожан в общей численности населения. Структура населения соответствует расширенному типу воспроизводства населения, в которой доля молодого населения в общей численности существенно превышает долю населения старших возрастов. Этот факт является определяющим при планировании мероприятий по повышению рождаемости, поскольку регион на данный момент обладает высоким потенциалом увеличения численности рожденных. Вместе с тем в Республике Ингушетия женщины преобладают над мужчинами в общей численности населения. Эта особенность может стать сдерживающим фактором повышения числа рождений в регионе, из-за чего необходимо планирование мер по укреплению репродуктивного здоровья мужчин.

2. РОЖДАЕМОСТЬ И ЕЕ СТРУКТУРА

За 2016 - 2021 годы в Республике Ингушетия наблюдается рост абсолютного числа рождений в регионе, что главным образом объясняется благоприятной возрастной структурой населения региона. Вместе с тем в разрезе город-село динамика числа рождений асимметрична: в городской местности наблюдается ежегодный рост вышеуказанного показателя, в то время как в сельской местности число рождений сокращается (за исключением 2021 года, в котором наблюдался рост в сравнении с 2020). Данная тенденция может объясняться процессом урбанизации, следствием которого является миграция населения, имеющего высокий репродуктивный потенциал, из сельской местности в городскую, из-за чего наблюдается рост числа рождений в городах и его падение в селах. Общее сокращение числа рождений в сельской местности составило за период 2016 - 2020 гг. 16,9% и, даже несмотря на рост в 2021 году на 3,7%, нет причин полагать, что в регионе будет наблюдаться дальнейший рост числа рождений в сельской местности. По данным за январь - декабрь 2022 года наблюдается сокращение абсолютного числа рождений, что может объясняться сокращением числа первых детей, рожденных более малочисленной когортой поколения конца 90-х, начала 00-х, которые в 2022 году перешли в возраст 15 - 25 лет.

Таблица 5. Динамика абсолютного числа рождений в Республике Ингушетия в разрезе город-село, 2016 - 2022

Тип поселения	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Январь - декабрь 2022	<1>
Всего	7 750	7890	8048	8252	8350	8504	7912	
Город	2 944	3679	3890	4118	4354	4361	н/д	
Село	4 806	4211	4158	4134	3996	4143	н/д	

<1> За январь - декабрь 2022 года нет данных по численности, родившихся в разрезе город-село.

В Республике Ингушетия отмечается устойчивая динамика общего коэффициента рождаемости (далее - ОКР) в расчете на 1000 населения за 2016 - 2021 годы. ОКР в регионе выше соответствующего значения по Российской Федерации как в целом, так и в разрезе город-село. ОКР региона в сельской местности существенно превышает соответствующий показатель в городской местности, что может объясняться культурно-демографическими традициями: дети являются основными социально-экономическими помощниками взрослых членов семьи.

Таблица 6. Динамика общего коэффициента рождаемости
в Республике Ингушетия, 2016 - 2022 гг.

Субъект	Тип поселения	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Январь - декабрь 2022
Республика Ингушетия	Всего	16,3	16,3	16,3	16,4	16,3	16,4	15,1
	Город	14,9	15,6	14,3	14,8	15,3	15,1	
	Село	17,3	16,9	18,9	18,5	17,6	18,0	
Российская Федерация	Всего	12,9	11,5	10,9	10,1	9,8	9,6	9,0
	Город	13,1	11,6	11,0	10,2	9,9	9,6	
	Село	12,2	11,2	10,7	9,8	9,6	9,5	

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

В разрезе очередностей рождения в Республике Ингушетия наблюдается рост числа первых (на 9,7%), вторых (на 3,7%), четвертых (2,9%), пятых и последующих детей (31,9%), в то время как сокращается число рождений третьих детей на 12,0 процента в 2021 году в сравнении с 2018 годом. В структуре рождений на 2021 год стали преобладать рождения низких очередностей - первого ребенка (22,1%) и второго ребенка (20,0%), а также крайне высоких порядков очередности - пятых и последующих детей (20,5%). Этот факт свидетельствует о существенной реструктуризации порядков очередности рождений, поскольку в 2018 году преобладали рождения третьих детей. Данная особенность Республики Ингушетия может объясняться доминированием социокультурных факторов, определяющих репродуктивное поведение. Эти особенности, с одной стороны, способствуют росту рождений старших порядков очередности, в то время как изменяющаяся возрастная структура населения и вступление в репродуктивный возраст младших возрастных когорт, наряду с федеральными и региональными демографическими мерами по повышению рождаемости, способствуют росту доли рождений младших порядков очередности в структуре родившихся детей. В то же время наблюдается сокращение числа рождений третьих детей. В связи с этим актуальным и эффективным направлением демографической политики будут меры по материальному стимулированию рождения третьих и четвертых по очередности детей при одновременном акценте на воспитательно-идеологической составляющей политики в области стимулирования рождаемости, которая заключается в укреплении семейных ценностей.

Рисунок 4. Структура абсолютного числа рождений
по порядкам очередности*

* Рисунок 4 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Суммарный коэффициент рождаемости (далее - СКР) в регионе демонстрировал ежегодный рост за период 2016 - 2021 годов, что свидетельствует о благоприятной репродуктивной ситуации в регионе. В разрезе город-село динамика суммарного коэффициента рождаемости менее однозначна.

В 2018 году в городской местности наблюдается существенное сокращение СКР с 1,74 (2017 год) до 1,6. Это может быть связано с особенностями культурных и социальных норм, ожиданий и предпочтений в отношении решений пар о рождении детей. Следует отметить, что в 2018 году была перераспределена численность городского и сельского населения. Прибывшая в город часть населения могла существенно исказить половозрастные показатели рождаемости за счет лага между переездом в городскую местность и решением о рождении детей (требуется время для благоустройства, трудоустройства и прочих тенденций, которые могут повлиять на откладывание рождений). Данную гипотезу косвенно подтверждает тот факт, что в 2021 году наблюдается стабилизация уровня СКР в городской местности до уровня 2017 года. Следует отметить, что в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости в Республике Ингушетия снизился до 1,83, что является подтверждением необходимости активизации мер демографической политики, влияющих на решение о рождении детей.

Таблица 7. Динамика суммарного коэффициента рождаемости

за 2016 - 2021 годы в разрезе город-село

Субъект	Тип поселения	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	Всего	1,75	1,77	1,79	1,83	1,85	1,87
	Город	1,64	1,74	1,60	1,67	1,76	1,75
	Село	1,83	1,80	2,04	2,02	1,97	2,02
Российская Федерация	Всего	1,76	1,62	1,58	1,50	1,50	1,50
	Город	1,67	1,53	1,49	1,43	1,43	1,44
	Село	2,06	1,92	1,87	1,75	1,74	1,73

Суммарный коэффициент рождаемости в разрезе очередностей рождения свидетельствует об относительно равном соотношении рождения детей различных порядков очередности. Эта особенность региона свидетельствует о совмещении различных моделей репродуктивного поведения - традиционной многодетной, которая заключается в высоком значении СКР самых старших порядков очередности, и молодой, суженной, которая заключается в более низком значении суммарного коэффициента рождаемости первых, вторых и третьих детей. Таким образом, при разработке мер демографической политики необходимо учитывать существенное превалирование рождений старших порядков очередности в структуре рождений, стимулировать рождаемость четвертых и последующих детей за счет монетарных мер поддержки и одновременно способствовать повышению рождаемости молодых возрастных когорт, которые принимают решение о рождении первых детей.

Рисунок 5. Динамика суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождения в регионе и в Российской Федерации, 2016 - 2021 гг.*

* Рисунок 5 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Динамика среднего возраста матери в Республике Ингушетия свидетельствует о росте данного показателя за 2018 - 2021 годы. На 2021 год средний возраст матери в Республике Ингушетия составил 28,9 лет, что выше соответствующего значения по Российской Федерации на 0,5 года. В структуре среднего возраста матери по очередности рождения в Республике Ингушетия следует выделить быстрый переход от одного ребенка к двум детям, в то время как интергенетический интервал между рождениями третьего и четвертого, а также четвертого и пятого ребенка составляет от двух до трех лет, что существенно выше соответствующих значений в Российской Федерации в среднем. Это свидетельствует о проблеме перехода от модели однодетной или двухдетной семьи к многодетной, из-за чего меры демографической политики следует направить на монетарную поддержку рождений третьих и последующих детей, что также следует из особенностей репродуктивного потенциала региона и структуры рождаемости по очередности рождений.

Таблица 8. Динамика среднего возраста матери за 2018 - 2021 в разрезе очередностей рождения

Субъект	Очередность	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	По всем детям	28,8	28,8	28,9	28,9
	Первого ребенка	24,9	24,9	24,8	24,8
	Второго ребенка	26,6	26,6	26,4	26,3
	Третьего ребенка	29,1	28,6	29,1	29,0
	Четвертого ребенка	31,1	31,3	31,4	31,3
	Пятого и последующих детей	34,0	34,0	34,2	34,2
Российская Федерация	По всем детям	28,2	28,2	28,3	28,4

Первого ребенка	25,4	25,4	25,4	25,5
Второго ребенка	29,2	29,2	29,1	29,1
Третьего ребенка	31,6	31,5	31,5	31,6
Четвертого ребенка	32,4	32,5	32,6	32,6
Пятого и последующих детей	33,8	34,0	34,0	34,0

За период 2016 - 2021 годов в Республике Ингушетия наблюдается существенное сокращение доли рожденных в браке детей. В 2016 году доля родившихся в браке составляла 84,7% и на состояние на 2022 год сократилась на 6,3 процентных пункта. Это может быть связано с происходящими изменениями в социальных и культурных установках общества, снижением роли традиционных семейных ценностей, увеличением числа незамужних или неженатых пар, а также сменой приоритетов в жизни людей. Данная особенность региона имеет несколько неблагоприятных объяснений. Во-первых, это может указывать на изменение отношения к браку и семье в обществе: люди все чаще выбирают неформальные отношения и предпочитают неофициально регистрировать свои отношения. Кроме того, сокращение доли рожденных в браке детей может влиять на демографическую ситуацию в регионе, так как браки часто предполагают более стабильные и долгосрочные отношения, которые способствуют рождению и воспитанию детей.

Таблица 9. Динамика доли детей, родившихся в браке, и доли детей, родившихся вне брака, от общего числа рождений

Субъект	Тип рождения	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	Родившиеся в браке	84,7%	83,6%	87,1%	90,1%	81,5%	78,4%
	Родившиеся вне брака	15,3%	16,4%	12,9%	9,9%	18,5%	21,6%
Российская Федерация	Родившиеся в браке	78,9%	78,8%	78,8%	79,1%	78,3%	78,0%
	Родившиеся вне брака	21,1%	21,2%	21,2%	20,9%	21,7%	22,0%

Отношение браков к разводам в Республике Ингушетия за 2016 - 2020 годы выше соответствующего значения по Российской Федерации. В 2020 году в сравнении с 2019 годом отношение браков к разводам сократилось с 4,9 до 3,7, а в 2021 в сравнении с 2020 - до 0,9, что ниже уровня по Российской Федерации.

Рисунок 6. Динамика отношения браков к разводам в регионе и в РФ за период 2016 - 2021 гг.*

* Рисунок 6 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

3. СТРУКТУРА ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Таблица 10. Структура женского населения фертильного возраста в разрезе однолетних возрастных групп по состоянию на 1 января 2022 года

Возраст	В абсолютном выражении			В долях от всей численности женщин		
	все население, чел.	городское население, чел.	сельское население, чел.	все население, %	городское население, %	сельское население, %
15	4 350	2 445	1 905	2,92%	2,91%	2,92%
16	4 592	2 662	1 930	3,08%	3,17%	2,96%
17	4 509	2 612	1 897	3,02%	3,11%	2,91%
18	4 406	2 532	1 874	2,95%	3,02%	2,87%

19	4 382	2 448	1 934	2,94%	2,91%	2,97%
20	3 974	2 172	1 802	2,66%	2,59%	2,76%
21	4 423	2 498	1 925	2,97%	2,97%	2,95%
22	4 343	2 412	1 931	2,91%	2,87%	2,96%
23	4 237	2 313	1 924	2,84%	2,75%	2,95%
24	4 133	2 210	1 923	2,77%	2,63%	2,95%
25	4 134	2 243	1 891	2,77%	2,67%	2,90%
26	4 345	2 410	1 935	2,91%	2,87%	2,97%
27	4 440	2 326	2 114	2,98%	2,77%	3,24%
28	4 187	2 124	2 063	2,81%	2,53%	3,16%
29	4 810	2 525	2 285	3,22%	3,01%	3,51%
30	4 637	2 446	2 191	3,11%	2,91%	3,36%
31	5 845	3 127	2 718	3,92%	3,72%	4,17%
32	5 447	2 952	2 495	3,65%	3,52%	3,83%
33	5 189	2 858	2 331	3,48%	3,40%	3,58%
34	5 240	2 968	2 272	3,51%	3,53%	3,49%
35	4 805	2 733	2 072	3,22%	3,25%	3,18%
36	5 453	3 158	2 295	3,66%	3,76%	3,52%
37	4 560	2 633	1 927	3,06%	3,14%	2,96%
38	4 496	2 634	1 862	3,01%	3,14%	2,86%
39	4 160	2 420	1 740	2,79%	2,88%	2,67%
40	3 643	2 076	1 567	2,44%	2,47%	2,40%
41	5 092	3 058	2 034	3,41%	3,64%	3,12%
42	3 577	2 142	1 435	2,40%	2,55%	2,20%
43	3 272	1 882	1 390	2,19%	2,24%	2,13%
44	2 933	1 764	1 169	1,97%	2,10%	1,79%
45	2 980	1 733	1 247	2,00%	2,06%	1,91%
46	3 549	2 157	1 392	2,38%	2,57%	2,14%
47	2 908	1 752	1 156	1,95%	2,09%	1,77%
48	3 148	1 834	1 314	2,11%	2,18%	2,02%
49	2 964	1 721	1 243	1,99%	2,05%	1,91%
15 - 49	149 163	83 980	65 183	52,45%	52,64%	52,20%
Всего	284 417	159 540	124 877			
женщин						

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

По состоянию на 1 января 2022 года женское население фертильного возраста Республики Ингушетия составило 149 163 человека, или 52,45% от всего женского населения региона, большая часть женского населения фертильного возраста сосредоточена в городской местности. Наибольшая доля женщин в репродуктивном возрасте как в городской, так и в сельской местности приходится на женщин в возрасте 31 - 36 лет, наименьшая доля приходится на женщин 42 - 49 лет. Распределение женского населения 15 - 49 лет по однолетним возрастным группам в городской и сельской местности практически идентично, однако в сельской местности отмечается более заметное преобладание женщин 27 - 36 лет и меньшая доля приходится на женщин старше 36 лет. Преобладание в возрастной структуре женщин 31 - 36 лет, на возраст которых, как правило, приходятся рождения высоких очередностей, может свидетельствовать о высокой доли третьих и последующих рождений в общей структуре рождений региона.

Таблица 11. Динамика численности женщин фертильного возраста
(15 - 49 лет) от общей численности женского населения
региона в целом, в разрезе город/село за период
2000 - 2026 годов

Год	Республика Ингушетия			Российская Федерация		
	все население	городское население	сельское население	все население	городское население	сельское население
2000	53,35%	55,62%	51,66%	50,71%	52,53%	45,64%
2001	55,93%	57,19%	54,99%	51,03%	52,82%	46,00%
2002	55,43%	56,32%	54,78%	51,38%	53,11%	46,49%
2003	55,01%	55,76%	54,47%	51,63%	53,28%	46,99%
2004	55,65%	56,56%	54,99%	51,70%	53,10%	47,72%
2005	56,27%	57,05%	55,70%	51,46%	52,64%	48,16%
2006	57,17%	57,79%	56,72%	51,21%	52,22%	48,37%
2007	57,27%	57,62%	57,01%	50,86%	51,78%	48,23%
2008	57,39%	57,41%	57,38%	50,38%	51,29%	47,74%
2009	57,01%	56,84%	57,14%	49,72%	50,65%	47,05%
2010	56,50%	56,06%	56,83%	49,06%	50,00%	46,35%
2011	55,37%	54,71%	55,79%	48,33%	49,28%	45,52%
2012	54,84%	54,42%	55,12%	47,56%	48,59%	44,52%
2013	54,52%	54,10%	54,80%	46,81%	47,91%	43,56%
2014	54,18%	53,81%	54,44%	46,16%	47,32%	42,67%
2015	53,90%	53,58%	54,12%	45,52%	46,72%	41,93%
2016	53,59%	53,27%	53,81%	45,02%	46,22%	41,42%
2017	53,43%	53,21%	53,58%	44,59%	45,78%	40,99%
2018	53,39%	53,18%	53,65%	44,32%	45,50%	40,71%
2019	53,25%	53,19%	53,32%	44,08%	45,25%	40,47%
2020	53,03%	53,16%	52,88%	43,88%	45,03%	40,34%
2021	52,43%	52,62%	52,19%	43,64%	44,74%	40,22%
2022	52,45%	52,64%	52,20%	43,60%	44,68%	40,23%
2023	52,51%	52,81%	52,12%	43,37%	44,39%	40,16%
2024	52,53%	52,87%	52,10%	43,26%	44,22%	40,20%
2025	52,55%	52,85%	52,16%	43,12%	44,05%	40,16%
2026	52,31%	52,54%	52,01%	42,92%	43,81%	40,07%

Динамика доли женщин фертильного возраста Республики Ингушетия относительно численности женского населения региона в целом за период 2000 - 2026 годов характеризуется как стабильная, минимальное значение прогнозируется в 2026 году - 52,31%, максимальное наблюдалось в 2008 году - 57,39%, при этом динамика рассматриваемого показателя идентична как в городской, так и в сельской местности. Вместе с тем наблюдаемая тенденция закономерного сокращения доли женщин фертильного возраста схожа с динамикой показателя по России в целом, в регионе сокращение доли женщин фертильного возраста ежегодно наблюдается с 2008 года, в Российской Федерации в целом данная тенденция закрепились с 2004 года.

На рисунке 7 представлено сравнение распределения женщин фертильного возраста в разрезе однолетних возрастных групп в Республике Ингушетия и в Российской Федерации в целом в 2000, 2010, 2020, 2023, 2023, 2025 и 2026 годах. На графиках отчетливо видно преобладание в структуре женщин фертильного возраста Республики Ингушетия девушек в возрасте 15 - 30 лет как относительно долей женщин в других возрастных группах в Республике Ингушетия, так и относительно аналогичной возрастной группы в Российской Федерации в целом. Данная особенность структуры женского населения в Республике Ингушетия, безусловно, является преимуществом региона и, вероятно, обеспечивает столь высокие (относительно других регионов России) показатели рождаемости. В преобладании женщин младших фертильных возрастов заключается демографический потенциал региона, обеспечивая высокие показатели рождений как в текущем периоде, так и в будущем, когда девушки младших фертильных возрастов вступят в брак и родят первенца.

Рисунок 7. Распределение женщин фертильного возраста в Республике Ингушетия и в Российской Федерации*

* Рисунок 7 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Рисунок 8. Распределение женщин фертильного возраста
в Республике Ингушетия и в Российской Федерации
(продолжение рисунка 7)*

* Рисунок 8 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Структура женщин фертильного возраста региона, имеющих определенное количество детей, обнаруживает существенное отличие от аналогичного распределения женщин по Российской Федерации в целом.

Таблица 12. Распределение женского населения фертильного
возраста в разрезе имеющегося у женщин числа детей, 2020 г.

Субъект	Не имеют детей	Один ребенок	Двое детей	Трое детей	Четверо детей	Пять и более детей	Не указавшие число детей
Республика Ингушетия	40,97%	4,72%	6,42%	7,18%	6,09%	6,46%	28,15%
Российская Федерация	20,84%	21,23%	19,92%	5,76%	1,29%	0,64%	30,33%

Преобладающим числом детей для женщин фертильного возраста Республики Ингушетия является три ребенка, в то время как для России в целом большинство женщин, ответивших на соответствующий вопрос о количестве детей (при прохождении Всероссийской переписи населения 2020 года) имеет одного ребенка. Вместе с тем в Ингушетии более 40% женщин фертильного возраста (что вдвое больше, чем аналогичный показатель по России в целом) не имеют детей, что является отражением особенностей структуры женского населения фертильного возраста Ингушетии. Если для России в целом к данной категории относятся как молодые женщины, еще не ставшие матерями в силу возраста, так и женщины более старших возрастов, которые не имели детей на протяжении всего репродуктивного периода, в Республике Ингушетия основную долю в данной категории женщин, вероятно, занимают молодые девушки, еще не вступившие в брак и не родившие первенца. При этом необходимо отметить, что распределение женщин, имеющих детей, в зависимости от количества детей, является практически равномерным: наименьшая доля - 4,72% женщин фертильного возраста имеет одного ребенка, наибольшая доля - 7,18% имеет троих детей. Данное распределение отчасти отражает, что репродуктивные установки у женщин региона практически не изменяются со временем, вероятно, для большинства женщин характерно иметь трех и более детей, что, учитывая относительно равномерную структуру распределения женщин фертильного возраста по однолетним возрастам, и проявляется в том, что более молодые женщины имеют одного или двоих детей (в силу того, что еще не успели родить ребенка более высокой очередности), женщины более старших возрастов являются, в основном, многодетными матерями. Поскольку выше отмечалось, что в структуре женщин репродуктивного возраста преобладают женщины 31 - 36 лет, а наименьшую долю составляют женщины 42 - 49 лет, наблюдается преобладание женщин с тремя детьми над женщинами с четырьмя и пятью и более детьми. Можно предположить, что через 5 лет данное распределение сместится в сторону рождений более высоких очередностей.

Структура женщин фертильного возраста Республики Ингушетия является одним из основных факторов, обеспечивающих региону высокие показатели рождений. Основным фактором, который позитивно влияет на рождаемость и обеспечивает высокий демографический потенциал региона, является наличие равномерной структуры женщин фертильного возраста, распределенной по однолетним возрастам. В отличие от большинства регионов России, где наблюдаются последствия "демографической ямы" 1990-х годов и малая доля женщин фертильного возраста 25 - 30 лет, в Республике Ингушетия данная закономерность практически не выражена. На долю женщин фертильного возраста до 30 лет приходится (по состоянию на 1 января 2022 года) 43,75% женщин репродуктивного возраста, в то

время как аналогичный показатель по России в целом составляет 31,93%. Учитывая также культурные традиции региона, в котором в меньшей степени наблюдается откладывание первых рождений, большинство женщин в регионе являются многодетными матерями.

Несмотря на то, что в регионе, как и в России в целом, наблюдается постепенное сокращение доли женщин фертильного возраста относительно всего женского населения, темпы снижения данного показателя меньше общероссийских, а в период 2022 - 2025 годов наблюдается и прогнозируется небольшой рост.

4. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Поскольку аборт не распространен в Республике Ингушетия отчасти в силу культурных особенностей (религиозные и общественные мнения признают аборт как убийство ребенка) показатели числа абортов в регионе в расчете на 1000 женщин фертильного возраста существенно ниже, чем по России в целом.

Таблица 13. Число абортов на 1 000 женщин
в возрасте 15 - 49 лет, 2018 - 2021 гг.

Субъект	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	6,2	6,0	5,4	5,7
Российская Федерация	18,9	17,9	16,0	15,1

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, все процедуры по прерыванию беременности проводятся в организациях государственных форм собственности.

Таблица 14. Распределение абортов в Республике Ингушетия
по возрасту женщины и форме государственной собственности
медицинской организации, 2016 - 2021

Число прерываний беременности (единица, значение показателя за год)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 - 17 лет	Негосударственная форма собственности		0				0
	Всего	2	0	1	4		0
	Государственная собственность		0	1	4		0
18 - 44 лет	Негосударственная форма собственности		0				0
	Всего	968	1 005	839	818	762	840
	Государственная собственность		1 005	839	818	762	840
45 - 49 лет	Негосударственная форма собственности		0				0
	Всего	63	5	39	46	31	1
	Государственная собственность		5	39	46	31	1
50 лет и старше	Негосударственная форма собственности		0				0
	Всего	49	0				0
	Государственная собственность		0				0
Всего	Негосударственная форма собственности						0
	Всего		879	868	793	841	
	Государственная собственность		879	868	793	841	

до 14 лет	Негосударственная форма собственности	0	0
	Всего	0	0
	Государственная собственность	0	0

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Основная доля абортс приходится на женщин 18 - 44 лет, крайне редки случаи аборта среди девушек 15 - 17 лет. Общая динамика характеризуется тенденцией снижения за период с 2018 по 2021 год.

Таблица 15. Сравнение показателя абортс в расчете на 1000 женщин фертильного возраста в Республики Ингушетия и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа

Субъект	2018	2019	2020	2021
Кабардино-Балкарская Республика	8,4	9,1	5,5	5,0
Республика Ингушетия	6,2	6,0	5,4	5,7
Республика Дагестан	6,9	7,0	6,2	6,2
Карачаево-Черкесская Республика	11,1	11,5	9,9	9,8
Республика Северная Осетия-Алания	12,4	12,1	10,5	10,7
Чеченская Республика	10,3	10,6	10,8	10,7
Ставропольский край	16,7	16,1	13,6	13,6
Российская Федерация	18,9	17,9	16,0	15,1

Республика Ингушетия в период 2018 - 2020 годов была регионом-лидером в силу наиболее благоприятной статистики абортс среди регионов Северо-Кавказского федерального округа, в 2021 году уступив первенство Кабардино-Балкарской Республике.

Таблица 16. Динамика абортс в расчете на 1000 женщин фертильного возраста за период 2016 - 2021 годов среди регионов-лидеров (по состоянию на 2021 год)

Субъект	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Кабардино-Балкарская Республика	10,6	8,7	8,6	9,2	5,6	5
Тульская область	13,9	11,5	9,6	8,5	8,4	5,7
Республика Ингушетия	7,8	6,9	6,1	6	5,4	5,7
Воронежская область	15,8	12,7	11,3	9,5	7,1	6,2
Республика Дагестан	8,6	6,8	7	6,9	6,1	6,2

Республика Мордовия	18,9	15,2	13,2	10,6	8,4	6,6
Белгородская область	12,5	10,3	9,7	9,3	7,7	6,8
Московская область	15,3	12,1	10,6	9,1	7,6	7,1
Тамбовская область	12,4	10,2	9,6	8,7	7,9	7,1
Город Москва	9,8	8,8	8,5	8,3	7,2	7,2

Относительно всех регионов России Республика Ингушетия также входит в число регионов-лидеров с наиболее благоприятными значениями показателей абортот - 3 место в общероссийском рейтинге.

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РОЖДЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ

Показатели, характеризующие уровень медицинской инфраструктуры в регионе, в особенности учреждений, оказывающих услуги акушерско-гинекологического профиля и родовспоможения, представлены в таблицах 18, 19, 20, 21.

Таблица 17. Основные показатели работы учреждений (подразделений) родовспоможения Республики Ингушетия

Показатель	2019 г.	2020 г.
Число женщин фертильного возраста		146411
Число родов (всего), из них:	7723	8223
- в акушерских стационарах I группы	0	0
- в акушерских стационарах II группы	2973	2193
- в акушерских стационарах III группы	4750	6029
Число преждевременных родов (22 - 27 недель) (всего), из них:	23	24
- в акушерских стационарах I группы	0	0
- в акушерских стационарах II группы	2	0
- в акушерских стационарах III группы	21	24
Число преждевременных родов (28 - 37 недель) (всего), из них:	226	296
- в акушерских стационарах I группы	0	0
- в акушерских стационарах II группы	24	36
- в акушерских стационарах III группы	202	260
Количество женщин с преждевременными родами (22 - 37 недель), родоразрешенных в перинатальных центрах (всего), из них:	223	286
- в сроке 22 - 27 недель	21	24
- в сроке 28 - 37 недель	202	260
Число нормальных родов (всего), из них:	2903	3094
- в акушерских стационарах I группы	0	0
- в акушерских стационарах II группы	1340	1405
- в акушерских стационарах III группы	1563	1689
Доля нормальных родов, % от общего числа родов, из них:	37,58	57,8
- в акушерских стационарах I группы	0	0

(% от общего числа родов в акушерских стационарах I группы)		
- в акушерских стационарах II группы	45,0	45,4
(% от общего числа родов в акушерских стационарах II группы)		
- в акушерских стационарах III группы	32,9	54,5
(% от общего числа родов в акушерских стационарах III группы)		
Число плановых кесаревых сечений (всего), из них:	1063	1150
- в акушерских стационарах I группы	0	0
- в акушерских стационарах II группы	316	199
- в акушерских стационарах III группы	747	951
Доля плановых кесаревых сечений, % от общего числа родов, из них:	13,8	13,9
- в акушерских стационарах I группы	0	0
(% от общего числа родов в акушерских стационарах I группы)		
- в акушерских стационарах II группы	10,6	9,0
(% от общего числа родов в акушерских стационарах II группы)		
- в акушерских стационарах III группы	15,7	15,7
(% от общего числа родов в акушерских стационарах III группы)		
Число экстренных кесаревых сечений (всего), из них:	788	975
- в акушерских стационарах I группы	0	0
- в акушерских стационарах II группы	181	156
- в акушерских стационарах III группы	607	819
Доля экстренных кесаревых сечений, % от общего числа родов, из них:	10,2	11,8
- в акушерских стационарах I группы	0	0
(% от общего числа родов в акушерских стационарах I группы)		
- в акушерских стационарах II группы	6,0	7,1
(% от общего числа родов в акушерских стационарах II группы)		
- в акушерских стационарах III группы	12,8	13,5
(% от общего числа родов в акушерских стационарах III группы)		
Показатель материнской смертности	0	11,8
Число случаев материнской смерти (всего), из них:	-	1
- в акушерских стационарах I группы	-	-
- в акушерских стационарах II группы	-	1
- в акушерских стационарах III группы	-	-
Показатель перинатальной смертности:	7,74	10,9
- мертворождаемость	5,11	7,3
- ранняя неонатальная смертность	2,63	3,6
Показатель младенческой смертности	5,9	5,6
Число абортот:	868	793
- из них по желанию	6	0
Показатель абортот на 1000 женщин фертильного возраста	6,0	5,4
Показатель абортот на 100 родившихся живыми и мертвыми	10,8	9,3

Таблица 18. Организация реанимационной помощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде, организация дистанционных и выездных форм

Показатель	2019 г.	2020 г.
Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин (всего), в том числе:	15	9
- в акушерских стационарах II группы	6	-
- в акушерских стационарах III группы	9	9
Число врачей - анестезиологов-реаниматологов в акушерских стационарах	30	13

Число врачей-трансфузиологов в акушерских стационарах	1	-
Количество акушерских дистанционных консультативных центров	1	1
- на базе какой медицинской организации созданы (перинатальный центр, областная многопрофильная больница, центр медицины катастроф и т.д.) (указать)	ГБУ "РКПЦ"	ГБУ "РКПЦ"
Количество женщин, проконсультированных специалистами акушерских дистанционных консультативных центров (всего), в том числе с:	610	1476
- презклампсией, эклампсией	69	127
- акушерскими кровотечениями	2	15
- экстрагенитальными заболеваниями	165	106
- сепсисом		-
- осложнениями родов		203
- расстройствами гемостаза		-
- осложнениями анестезии		-
- прочими осложнениями	374	1025
Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад	1	1
- на базе каких медицинских организаций функционируют (перинатальный центр, областная многопрофильная больница, центр медицины катастроф и т.д.) (указать)	ГБУ "РКПЦ"	ГБУ "РКПЦ"
Количество реанимобилей для женщин	1	1
Количество реанимобилей для новорожденных	1	1
Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами (всего), в том числе с:	47	38
- презклампсией, эклампсией	8	16
- массивной кровопотерей	1	-
- экстрагенитальными заболеваниями	4	20
- сепсисом	-	-
- осложнениями анестезии	-	-
- прочими осложнениями	34	2
Количество вылетов санитарной, авиации (всего), в том числе к:	санавиации	санавиации
	нет	нет
- беременным женщинам	-	-
- роженицам	-	-
- родильницам	-	-
- новорожденным	-	-
- гинекологическим больным	-	-
Количество пациентов, эвакуированных санитарной авиацией (всего), в том числе:	-	-
- беременных женщин	-	-
- рожениц	-	-
- родильниц	-	-
- новорожденных	-	-
- гинекологических больных	-	-
Число пациентов, проконсультированных с использованием телемедицинских технологий сотрудниками акушерских дистанционных консультативных центров субъектов Российской Федерации (всего), в том числе:	28	63
- беременные женщины	27	19
- роженицы	-	-
- родильницы	1	11
- новорожденные	18	30
- гинекологические больные	-	3
Структура обращений для телемедицинского консультирования в акушерские дистанционные консультативные центры субъектов Российской Федерации:	28	63
- презклампсия, эклампсия		5
- акушерские кровотечения	-	-
- экстрагенитальные заболевания	4	4

- сепсис	-	-
- осложнения родов	1	-
- расстройства гемостаза	3	-
- прочие	20	54
Число пациентов, проконсультированных с использованием телемедицинских технологий сотрудниками ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России (всего), в том числе:	25	33
- беременные женщины	19	23
- роженицы		-
- родильницы	1	-
- новорожденные	5	10
- гинекологические больные		-
Структура обращений для телемедицинского консультирования в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России	25	33
- презклампися, эклампися	-	5
- акушерские кровотечения	-	-
- экстрагенитальные заболевания	2	4
- сепсис		-
- осложнения родов	1	-
- расстройства гемостаза	2	-
- прочие	20	24

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Таблица 19. Организация медико-социальной помощи
в женских консультациях и акушерских стационарах

Показатель	2019 г.	2020 г.
Количество женских консультаций (акушерско-гинекологических кабинетов) с наличием в штате специалиста по социальной работе	1	1
Количество специалистов по социальной работе в учреждениях родовспоможения субъекта (всего), в том числе:	2	1
- в женских консультациях (акушерско-гинекологических кабинетах)	2	1
- в акушерских стационарах	0	-
Количество женских консультаций (акушерско-гинекологических кабинетов) с наличием в штате психолога	1	2
Количество психологов в учреждениях родовспоможения субъекта (всего), в том числе:	1	2
- в женских консультациях (акушерско-гинекологических кабинетах)	2	2
- в акушерских стационарах	-	-
Количество женских консультаций (акушерско-гинекологических кабинетов), имеющих в структуре кабинеты медико-социальной помощи	3	3
Количество женщин, обратившихся (направленных) в кабинеты медико-социальной помощи	77	15
Деятельность центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее - Центр)		
Количество Центров в субъекте Российской Федерации	-	-
Количество женщин, обратившихся (направленных) в Центры	-	-

Количество методических рекомендаций для специалистов по социальной работе и психологов женских консультаций и акушерских стационаров, разработанных Центром		
Количество организованных телефонов доверия	3	-
Наличие сайта в сети "Интернет", пропагандирующего позитивное отношение к родительству и позиционирующего результаты работы Центра (да/нет)		
Количество женщин, обратившихся в женские консультации за направлением на аборт (всего)	77	31
- из них проконсультированы в кабинетах медико-социальной помощи как оказавшиеся в трудной жизненной ситуации	7	15
- из числа женщин, проконсультированных в кабинетах медико-социальной помощи, отказались от искусственного прерывания беременности (встали на учет по беременности)	71	15
	(из них 5 находящихся в ТЖС)	

Таблица 20. Совершенствование оказания медицинской помощи
большим акушерско-гинекологического профиля и новорожденным

N	Наименование индикатора	Единица измерения	2013 год	2017 год
			(по состоянию на 01.01.2014)	(по состоянию на 01.01.2018, план)
1.	Количество акушерских коек (всего), <*> в том числе:	количество	230	280
2.	- в учреждениях родовспоможения I группы	количество	5	5
3.	- в учреждениях родовспоможения II группы	количество	225	195
4.	- в учреждениях родовспоможения III группы	количество	0	80
5.	Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин (всего), в том числе:	количество	6	15
6.	- в учреждениях родовспоможения II группы	количество	6	6
7.	- в учреждениях родовспоможения III группы	количество	0	9
8.	Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (всего), в том числе:	количество	12	30
9.	- в учреждениях родовспоможения	количество	12	30
10.	- в детских больницах	количество	0	0
11.	Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) всего, в том числе:	количество	29	44
12.	- в учреждениях родовспоможения	количество	14	44
13.	- в детских больницах	количество	15	0
14.	Число родов в стационаре (всего), в том числе:	число	9333	8000
15.	- в учреждениях родовспоможения I группы	число	56	30
16.	- в учреждениях родовспоможения II группы	число	9277	4770
17.	- в учреждениях родовспоможения III группы	число	0	3200
18.	Число преждевременных родов (22 - 37 недель), всего, в том числе:	число	498	400
19.	- в учреждениях родовспоможения I группы	число	0	0
20.	- в учреждениях родовспоможения II группы	число	498	120
21.	- в учреждениях родовспоможения III группы	число	0	280
22.	Среднегодовая занятость акушерской койки:			
23.	- в учреждениях родовспоможения I группы	число дней работы койки в году	65	144
24.	- в учреждениях родовспоможения II группы	число дней работы койки в году	358	290
25.	- в учреждениях родовспоможения III группы	число дней работы койки	0	310

	в году		
26. Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке патологии беременности:			
27. - в учреждениях родовспоможения I группы	дней	0	0
28. - в учреждениях родовспоможения II группы	дней	11,2	8,2
29. - в учреждениях родовспоможения III группы	дней	0	8,8
30. Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке беременных и рожениц:			
31. - в учреждениях родовспоможения I группы	дней	5,9	4,8
32. - в учреждениях родовспоможения II группы	дней	6,5	5,4
33. - в учреждениях родовспоможения III группы	дней	0	6,0
34. Число врачей акушеров-гинекологов	число	170	190
35. Число врачей-неонатологов	число	21	45
36. Число врачей анестезиологов-реаниматологов в учреждениях родовспоможения (в отделениях акушерского профиля)	число	11	18
37. Число врачей анестезиологов-реаниматологов (в отделениях неонатологического профиля)	число	4	15
38. Количество акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров	количество	0	1
39. Количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных сотрудниками акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров	количество	0	2800
	доля % от числа закончивших беременность	0	35
40. Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад в составе перинатальных центров	количество	0	1
41. Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами в составе перинатальных центров	количество	0	10
	доля % от числа закончивших беременность		0,12
42. Материнская смертность	количество случаев на 100000 родившихся живыми	1 12,8	1 12,8
43. Младенческая смертность	на 1000 родившихся живыми	13,8	10,1
44. Перинатальная смертность	на 1000 родившихся живыми и мертвыми	15,7	11,6
45. Мертворождаемость	на 1000 родившихся живыми и мертвыми	8,5	7,4
46. Ранняя неонатальная смертность	на 1000 родившихся живыми	7,3	4,2

Регион успешно участвует в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография", реализует государственную программу Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения". В 2022 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в республике реализовывались шесть региональных проектов, направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи, модернизацию первичного звена здравоохранения республики, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами.

В рамках программы "Земский доктор" в 2022 году было запланировано трудоустроить 49 врачей с целью привлечения в труднодоступные сельские районы республики и устранения дефицита в кадрах. За семь месяцев текущего года диспансеризацию прошли лица трудоспособного возраста в количестве - 23 852 человека, а профилактические осмотры - 19463. Мобильными бригадами осмотрено 8799 человек.

Детская инфраструктура, в особенности учреждения дошкольного и школьного образования, в регионе активно развивается и совершенствуется. В текущем году в регионе ведется строительство 21 школы, рассчитанной на 14 тысяч ученических мест, и 9 детских садов, рассчитанных на 2 тысячи посадочных мест. Планируются к вводу 12 многофункциональных центров "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей. Двухсменный режим обучения сохраняется в 52 школах, к концу года планируется сократить их количество до восьми - девяти, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим. В 2021 году в республике были созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 71 общеобразовательной организации в рамках национального проекта "Образование". В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" был проведен ремонт спортивных залов в 21 школе, установлены спортивные площадки в 29 общеобразовательных организациях и созданы спортклубы в 43 школах. Чтобы дети могли безопасно и удобно добираться до школы, приобретено 80 школьных автобусов.

В настоящее время в Ингушетии функционируют 134 общеобразовательные организации и 94 дошкольных образовательных учреждения. Дефицит посадочных мест в школах по состоянию на конец 2021 года составлял почти 24,3 тысячи мест, в детских садах - 2,6 тысячи мест.

Показатель доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста в Ингушетии вырос за последние полтора года почти в два раза. В некоторых сельских поселениях первые ясельные группы были открыты в 2021 году. Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет увеличился с 49% до 82% (с января 2020 года по настоящее время). Такого результата удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию в регионе 18 детсадов в рамках нацпроекта "Демография" и федеральных программ.

В детских садах, расположенных в самом крупном городе республики - Назрани и отдаленных сельских поселениях Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши и Средние Ачалуки, будет дополнительно открыто 340 ясельных мест.

Также по линии Минсельхоза региона в возрождаемом селе Вежарий-Юрт строится детсад на 140 мест, в котором будет создано 40 мест для детей до 3 лет.

Для некоторых населенных пунктов - Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант и Вежарий-Юрт дошкольные учреждения станут первыми в селах. Кроме того, в данное время ведется строительство девяти детских садов в рамках национального проекта "Демография". Отмеченные процессы, имеющие место в регионе с целью повышения доступности дошкольного и школьного образования для детей республики, позволяют планомерно двигаться к стопроцентному обеспечению доступности дошкольного образования в республике, в частности, для детей до трех лет.

Уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста в регионе существенно ниже общероссийского показателя, однако в рассматриваемом периоде 2019 - 2021 годов наблюдается рост уровня занятости рассматриваемой категории женщин. Отчасти данные закономерности объясняются, опять же, влиянием культурных особенностей и традиций региона, характерного для него уклада жизни.

Таблица 21. Динамика уровня занятости

женщин с детьми дошкольного возраста

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Субъект	Показатель	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	Уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста	54,6	53,1	57,1
Российская Федерация	Уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста	67	66	67,1

Отчасти столь невысокий уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста может быть обусловлен тем, что женщины предпочитают не выходить на работу, посвятив себя семейной жизни и воспитанию детей. Данное предположение отчасти подтверждается тем, что 6 из 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа в период 2019 - 2021 годов включались в список десяти регионов с наименьшим уровнем занятости женщин с детьми дошкольного возраста (см. таблицу 22). Вместе с тем, поскольку Республика Ингушетия входит в пятерку регионов с наиболее низким уровнем занятости населения в целом, на наблюдаемые показатели занятости женщин с детьми дошкольного возраста может оказывать влияние и общая ситуация на региональном рынке труда (см. таблицу 23).

Таблица 22. Рейтинг регионов с наименее низким уровнем
занятости женщин дошкольного возраста
(по состоянию на 2021 год)

Субъект	2019	2020	2021
Республика Дагестан	45,9	42,6	43,4
Республика Северная Осетия-Алания	48,4	41,5	46
Карачаево-Черкесская Республика	48,3	48,1	49,4
Город Севастополь	44,9	41,5	50,2
Республика Крым	53,2	57,8	53,6
Кабардино-Балкарская Республика	53,2	51	54,3
Ставропольский край	58,4	56,1	56
Республика Ингушетия	54,6	53,1	57,1
Московская область	58,3	57,9	57,5
Республика Адыгея (Адыгея)	61,9	62,3	57,8

В Республике Ингушетия наблюдаются значительно более низкие показатели обеспеченности жилой площадью. Так, в 2021 году в городах республики на 1 жителя приходилось 17,02 квадратных метра жилой площади, в то время как норматив составляет 28 квадратных метров на 1 человека. При этом в 2016 году данный показатель обеспеченности жильем в регионе составлял 20,1 квадратных метра, после чего в 2017 году наблюдалось резкое падение обеспеченности жилой площадью до 15,6 квадратных метра. В период 2015 - 2021 годов отмечается положительная динамика показателя, однако темпы роста невелики. При этом в сельской местности наблюдается обратная тенденция - в 2017 году обеспеченность жилой площадью в расчете на 1 человека возросла с 11 квадратных метров до 14,3, после чего наблюдалось равномерное снижение показателя. Наблюдаемая резкая смена обеспеченности жильем в период 2016 - 2017 годов в городской и сельской местности Республики Ингушетия, вероятно, объясняется имевшим место изменением административно-территориального деления Ингушетии, когда поселок городского типа Сунжа был преобразован путем отнесения к категории городов республиканского значения, не влекущего изменения ранее

установленных границ преобразуемого населенного пункта, в ноябре 2016 года.

Таблица 23. Динамика общей площади жилых помещений, приходящихся в расчете на 1 жителя субъекта (в расчете на конец года) в целом по субъекту и по Российской Федерации, и в разрезе город/село за период 2016 - 2021 гг.

Субъект	Тип поселения	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	Всего	14,8	15	15,3	15,54	15,65	15,67
	Город	20,1	15,6	16,1	16,62	16,95	17,02
	Село	11	14,3	14,2	14,19	14,01	13,97
Российская Федерация	Всего	24,9	25,2	25,8	26,28	24,9	27,78
	Город	24,5	24,8	25,4	25,93	26,72	27,62
	Село	26,1	26,6	26,9	27,33	27,5	28,25

Вместе с тем в регионе наблюдаются одни из самых высоких (относительно всех регионов страны) показатели благоустроенности жилья. По состоянию на 2021 год 89,98% жилой площади в республике было оборудовано одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами. В рейтинге регионов России Республика Ингушетия занимает пятое место, опережая Москву, по уровню благоустройства жилья. Также отмечается позитивная тенденция устойчивого повышения данного показателя.

Таблица 24. Динамика показателя "Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда" субъекта за период 2016 - 2021 гг.

Субъект	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	75,7	77,8	83	84,1	89,94	89,98
Российская Федерация	66	66,6	67,2	68,6	69,46	70,49

Проблема обеспеченности жильем в регионе находит свое отражение и в статистике семей, стоящих в очереди на получение жилья. Так, число молодых семей, стоявших на учете в качестве нуждающихся в получении жилья в период 2017 - 2021 годов, увеличивалось, при этом статистика числа семей, получивших жилье, напротив, демонстрировала тенденцию снижения данного показателя.

Субъект	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	2 179	1 715	2 770	2 093	3 318	3 332
Российская Федерация	387 683	357 817	331 601	312 855	292 700	258 563

Число молодых семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия за период 2016 - 2021 гг.

Субъект	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	-	-	29	24	6	5
Российская Федерация	22 768	21 968	22 765	23 228	20 555	17 421

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от числа молодых семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, за соответствующий год

Республика Ингушетия			1,05%	1,15%	0,18%	0,15%
Российская Федерация	5,87%	6,14%	6,87%	7,42%	7,02%	6,74%

Аналогичные тенденции наблюдаются и при анализе статистики обеспеченности жильем многодетных семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При этом с 2016 года наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа таких семей, а в период 2019 - 2020 годов и в период 2020 - 2021 годов число таких семей увеличилось в 2,6 и в 1,8 раза соответственно.

Таблица 25. Число многодетных семей, стоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях за период
2016 - 2021 гг. <2>

<2> Данные о числе многодетных семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия за период 2016 - 2021 гг., отсутствуют.

Субъект	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Ингушетия	94	98	579	613	1 621	2 894
Российская Федерация	129 207	131 585	132 587	132 389	134 099	133 838

Таким образом, несмотря на преимущества региона с точки зрения структуры женского населения и показателей рождаемости, в Республике Ингушетия наблюдаются инфраструктурные проблемы, которые могут оказывать негативное влияние на благосостояние семей с детьми и на решение населения о рождении детей. В частности, наиболее острой является проблема обеспеченности жильем, которая проявляется в одном из наиболее низких в России значений соответствующего показателя (по состоянию на 2021 год показатель ниже только в Республике Тыва). Из года в год растет число молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении и стоящих в очереди на получение жилья, при этом крайне малая доля из них действительно улучшают жилищные условия.

IV. ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Демографический потенциал Республики Ингушетия выгодно выделяет регион в числе других регионов России, в которых демографическая ситуация является значительно менее благоприятной. В Республике Ингушетия сложилась благоприятная ситуация роста численности населения как за счет естественной компоненты - превышения числа рожденных над числом умерших, так и за счет миграционного прироста. Структура женщин фертильного возраста Республики Ингушетия является одним из основных факторов, обеспечивающих региону высокие показатели рождений. Основным фактором, который позитивно влияет на рождаемость и обеспечивает высокий демографический потенциал региона, является наличие равномерной структуры женщин фертильного возраста, распределенной по однолетним возрастам. Несмотря на то, что в регионе, как и в России в целом, наблюдается постепенное сокращение доли женщин фертильного возраста относительно всего женского населения, темпы снижения данного показателя меньше общероссийских, а в период 2022 - 2025 годов наблюдается и прогнозируется небольшой рост. Позитивную роль в благоприятной демографической ситуации региона играют и культурные особенности региона, традиции и уклад жизни населения, в частности, сравнительно более раннее вступление в брак, семейные установки с ориентиром на многодетность.

Вместе с тем инфраструктурные проблемы, такие как недостаточность мест в учреждения дошкольного образования на некоторых территориях республики, малая обеспеченность населения жильем негативно сказываются на уровне жизни семей с детьми, а также могут способствовать откладыванию решений о рождении ребенка.

Особую роль в формировании сложившейся демографической ситуации играет и уровень социально-экономического развития региона. В настоящее время Республика Ингушетия является регионом с одним из самых высоких показателей уровня бедности, отмечаются сравнительно низкий уровень среднедушевых денежных доходов населения. Причинами низкого уровня жизни, высокого показателя бедности в регионе являются: высокий уровень безработицы, инфляция, относительно низкий уровень оплаты труда, многодетность, низкий размер пенсий, стипендий.

Таблица 26. Уровень денежных доходов населения
в целом по России и по субъектам СКФО за 2022 г.

Регион	Денежные доходы в расчете на душу населения, руб./месяц
Российская Федерация	36073
Северо-Кавказский федеральный округ	24427
Республика Ингушетия	19 975
Кабардино-Балкарская Республика	30 843
Карачаево-Черкесская Республика	22 061
Республика Северная Осетия-Алания	28 949

Низкий социально-экономический уровень, наличие большого числа мигрантов, один из наиболее высоких уровней безработицы в значительной мере формируют неблагоприятные демографические показатели республики.

Несмотря на то что 30,5% населения на 2022 год имеют доход ниже прожиточного минимума (или официально считаются "бедными"), по Республике Ингушетия отмечаются стабильно высокие показатели рождаемости, высокие показатели естественного и миграционного прироста.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования региональной программы на период до 2025 года производится за счет средств федерального и республиканского бюджетов (приложение 2 к региональной программе "Комплекс мер региональной программы по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми").

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Средства бюджетов, направляемые на реализацию мероприятий "дорожной карты", подлежат ежегодному уточнению после их принятия на очередной финансовый год.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация региональной программы предполагает объединение усилий и координацию действий государственных органов власти, общественных объединений и организаций, направленных на повышение рождаемости, улучшение демографической ситуации в Республике Ингушетия, разработку и реализацию мероприятий в области образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты, молодежной политики, включая мероприятия, направленные на улучшение положения детей, женщин, семьи.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате исполнения мероприятий региональной программы, внедрения здорового образа жизни, проведения мероприятий по профилактике и своевременному выявлению тяжелых заболеваний, созданию условий для комфортной жизнедеятельности населения будут реализованы меры по повышению рождаемости и преодолению сложившихся негативных тенденций в демографическом развитии Республики Ингушетия на период до 2025 года.

Таблица 27. Ожидаемые результаты реализации региональной программы

		2023 год 2024 год 2025 год		
		план	план	план
1	2	3	4	5
Плановая численность родившихся (за год) человек		7320	7370	7550

Приложение 1
к региональной программе
Республики Ингушетия
по повышению рождаемости
на период 2023 - 2025 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ НА ПЕРИОД С 2023 - 2025 ГОД

N п/ п	Наименование показателя	Ед. изм.	Целевое значение показателя		
			2023	2024	2025
1.	Количество рождений в год	чел.	7320	7370	7550
2.	Количество абортс в абсолютном выражении	чел.	300	320	350
3.	Доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности до 12 недель после доабортного консультирования	%	28,0	35,0	50,0
4.	Общее число циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)	чел.	300	350	450
5.	Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию женского населения, в том числе женщин в возрасте 18 - 35 лет	%	65,3	70,0	75,0
6.	Показатели укомплектованности медицинских организаций в республике врачами-педиатрами	%	65,0	70,5	80,0
7.	Показатели укомплектованности медицинских организаций в республике врачами-неонатологами	%	55,0	57,0	59,0
8.	Показатели укомплектованности медицинских организаций в республике врачами - акушерами-гинекологами	%	92,7	92,7	93,0

Приложение 2
к региональной программе
Республики Ингушетия
по повышению рождаемости
на период 2023 - 2025 годов

КОМПЛЕКС МЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ НА ПЕРИОД 2023 - 2025 ГОДОВ

(в ред. [Постановления Правительства Республики Ингушетия от 15.12.2023 N 175](#))

N п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Источники финансирования
Задача 1. Укрепление репродуктивного здоровья и сокращения числа абортoв					
1.1	Внедрение в работу врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, положительных установок на рождение детей	Уменьшение числа абортoв среди женщин в возрасте от 18 до 35 лет. 100% внедрение в женских консультациях использования речевых модулей	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Не требуется
1.2	Внедрение мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся за медицинской услугой по прерыванию беременности	Отказ от аборта, сохранение беременности, повышение рождаемости, охрана репродуктивного здоровья населения, профилактика абортoв	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Не требуется
1.3	Организация диспансеризации женщин в возрасте 15 - 39 лет	Предоставление комплекса профилактических мероприятий, которые включают в себя как плановый медицинский осмотр, так и ряд дополнительных методов обследования. Оценка общего состояния здоровья человека, а также выявление на самом раннем этапе возможных проблем (например, хронические заболевания, которые еще не успели явно проявить себя характерными симптомами) и принятие мер для их профилактики	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Не требуется
1.4	Психологическая адресная помощь беременной женщине, желающей прервать беременность	Отказ от аборта, сохранение беременности, уменьшение числа абортoв путем оказания помощи детям и семьям с детьми по самым разным вопросам: от разрешения экстренной ситуации до консультирования, предоставление мер поддержки по принципу "одного окна", индивидуальное сопровождение до момента родов	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Не требуется
1.5	Информирование беременных женщин о доступных федеральных и	Проведение внемедийных мероприятий с участием целевых аудиторий граждан. Размещение информации в	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Не требуется

региональных мерах поддержки	печатных и электронных региональных средствах массовой информации, а также на сайтах и в социальных сетях информационно-разъяснительных материалов		Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	
1.6 Проведение диспансеризации студентов высших и средних профессиональных учебных заведений с акцентом на репродуктивное здоровье, с целью диагностики, лечения, реабилитации студентов с выявленными заболеваниями репродуктивной сферы	Раннее выявление заболеваний репродуктивной сферы, повышение рождаемости	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Не требуется
1.7 Санаторно-курортное лечение женщин фертильного возраста и мужчин с воспалительными заболеваниями	Улучшение репродуктивного здоровья, повышение рождаемости	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Республиканский бюджет
1.8 Увеличение числа бесплодных пар, направленных на оказание вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение)	Повышение доступности лечения бесплодия супружеских пар и одиноких женщин, желающих иметь детей, методами вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение). В целях 100% охвата нуждающихся бездетных пар и женщин, желающих иметь детей, широкое использование возможности всех учреждений за счет базовой программы обязательного медицинского страхования	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования
1.9 Усиление роли кризисных центров по прерыванию беременности путем оказания правовой, психологической и медико-социальной поддержки беременным женщинам	Уменьшение числа аборт, повышение рождаемости. Оказание медико-социальной и юридической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактика отказов от детей	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Не требуется
1.10 Улучшение качества подготовки специалистов	Систематическое повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров службы охраны материнства и детства, обучение врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов в ведущих федеральных центрах	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения Республики Ингушетия	Республиканский бюджет
1.11 Мониторинг аборт и их осложнений.	Раннее выявление заболеваний, сохранение репродуктивного здоровья	2023 - 2025 годы	Министерство здравоохранения	Не требуется

Ведение реестра женщин с самопроизвольными абортами в анамнезе, выявление причин невынашивания беременности		Республики Ингушетия		
Задача 2. Поддержка молодых студенческих семей и работающих родителей				
2.1 Перевод на бюджетные места девушек, родивших ребенка во время обучения в организациях профессионального образования	Порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное регулируется Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное". При наличии вакантных мест женщины, родившие во время обучения ребенка, будут переведены на бюджетные места	2023 - 2025 годы	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	Не требуется
2.2 Установление преимущественного права студенческой семье на предоставление мест в общежитиях и предоставление комнаты родителям-студентам	Поддержка молодых студенческих семей, стимулирование рождаемости в молодых семьях	2023 - 2025 годы	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	Не требуется
2.3 Установление приоритетного права студенческим семьям при оформлении ребенка в детский сад, школу	Обеспечение доступности и качества дошкольного и общего образования для всех детей дошкольного и школьного возрастов, в том числе и для детей, проживающих в студенческих семьях. В Республике Ингушетия доступность дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 3 лет - 100%, от 3 до 7 лет составляет 100%	2023 - 2025 годы	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	Не требуется
2.4 Предоставление беременным женщинам и женщинам с детьми до 3 лет гибких, дистанционных форм занятости (обязательства работодателей при наличии возможности)	Расширение возможностей для совмещения трудовой деятельности и воспитания детей	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Не требуется

3.1	Перевод мер поддержки многодетных семей в проективный формат по факту установления статуса "многодетная семья"	Повышение качества предоставления мер поддержки многодетным семьям	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Не требуется
3.2	Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей детей до 6 лет из многодетных семей	Охрана здоровья малолетних детей	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Республиканский бюджет
3.3	Предоставление единовременной материальной помощи детям из малообеспеченных семей к школе в размере 8 190 рублей	Социальная поддержка детей из многодетных семей, увеличение количества многодетных семей	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Республиканский бюджет
3.4	Информирование сторон социального партнерства о возможности включения в коллективные договоры пунктов, предусматривающих предоставление работникам, имеющим несовершеннолетних детей и совмещающим трудовую деятельность с семейными обязанностями, дополнительных гарантий и преимуществ	Повышение информированности сторон социального партнерства о мерах поддержки работников, имеющих несовершеннолетних детей	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Не требуется
3.5	Анализ действующих мер поддержки семей с точки зрения их достаточности (размер), условий получения, доступности и удобства обращения за назначением мер (в том числе соответствие принципам Социального казначейства)	Повышение эффективности мер поддержки семей с детьми путем оказания реальной (прямой) государственной поддержки. Проведение анализа, при необходимости внесение изменений в нормативные правовые акты	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Не требуется
3.6	Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей	Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в летний и другие каникулярные периоды	2023 - 2025 годы	Министерство образования и науки Республики Ингушетия Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия	Республиканский бюджет
3.7	Анализ достаточности мест в группах продленного дня для детей в возрасте до 10 лет, при необходимости введение дополнительных мест	Увеличение количества групп продленного дня в общеобразовательных организациях.	2023 - 2025 годы	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	Не требуется

	Группами продленного дня охвачено 6867 учащихся			
3.8	Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций, внедрение эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	Повышение статуса института семьи и брака, рождения детей	2023 - 2025 годы	Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетии Министерство образования и науки Республики Ингушетия Республиканский бюджет
Задача 4. Формирование ценностей основы повышения рождаемости				
4.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании, предусматривающей формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа многодетной семьи, многодетной матери, повышение мотивации семей к рождению детей	Проведение классных часов в образовательных организациях	2023 - 2025 годы	Министерство образования и науки Республики Ингушетия Не требуется
4.2	Организация работы "Школ родительства" на базе социальных организаций и дошкольных и общеобразовательных организаций	Формирование семейно-ориентированной среды, включение повестки многодетности в контекст жизни во всех сферах деятельности	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия Министерство образования и науки Республики Ингушетия Не требуется
4.3	Участие во Всероссийском конкурсе сочинений 2023 года тематического направления, связанного с семейными ценностями и традициями	Содействие формированию у детей традиционных духовно-нравственных ценностей	2023 - 2025 годы	Министерство образования и науки Республики Ингушетия Не требуется
4.4	Подготовка материалов на награждение многодетных семей орденом "Родительская слава", поощрение награжденных	Повышение общественного престижа семейного образа жизни, семейных ценностей, статуса и роли семьи в обществе	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия Республиканский бюджет
4.5	Проведение общественно значимых мероприятий, направленных на пропаганду жизни, семейных ценностей, повышение статуса родительства,	Повышение общественного престижа семейного образа жизни, семейных ценностей, статуса и роли семьи в обществе, укрепление семейных традиций путем	2023 - 2025 годы	Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия Республиканский бюджет

формирование в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов	проведения следующих мероприятий: - регионального конкурса "Семья года" и представления победителей на Всероссийский конкурс; - республиканского мероприятия, посвященного Дню семьи; - Международного Дня отца; - награждения многодетных матерей, имеющих пять и более детей, почетным знаком РИ "Материнская слава"; - республиканского мероприятия, посвященного Дню матери; - чествования семей - участников Всероссийского конкурса "Семья года"	Заинтересованные ведомства
Задача 5. Финансовые меры поддержки семей с детьми		
5.1 Единовременное денежное пособие семьям при рождении: - пятого ребенка - 5000 рублей; - на каждого последующего ребенка сумма увеличивается на 2000 рублей; - одновременно на двух детей - 30000 рублей; - одновременно на трех и более - в размере 100000 рублей	Оказание поддержки семей с многодетными родителями и стимулирование рождаемости в республике	2023 - 2026 Министерство труда, Республиканский занятости и социального развития Республики Ингушетия бюджет
5.2 Компенсация в размере 30% от расходов на оплату отопления, водоснабжения, водоотведения, газа и электроэнергии; перевод мер многодетных семей в проактивный формат по факту установления статуса "многодетная семья"	Оказание поддержки семей с многодетными родителями	2023 - 2025 Министерство труда, Республиканский занятости и социального развития Республики Ингушетия бюджет
Задача 6. Создание условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей		
6.1 Проработка вместе с работодателями механизмов поощрения работников с семейными обязанностями и детьми	Обеспечение работающих родителей полноценными условиями для совмещения работы и воспитания детей	2023 - 2025 Министерство труда, Не требуется занятости и социального развития Республики Ингушетия
Задача 7. Повышение информированности о мерах социальной поддержки семей с детьми		
7.1 Повышение уровня осведомленности женщин о возможности получения	Создание кризисных центров	2023 - 2025 Министерство труда, Не требуется занятости и социального развития

помощи в кризисных центрах для беременных женщин			Республики Ингушетия
7.2 Разработка и распространение информационно- разъяснительных материалов, направленных на популяризацию и продвижение семейных ценностей	Подготовка информации о лучших практиках реализации мероприятий (проектов, программ, видеофильмов) родительского просвещения и семейного воспитания	2023 - 2025	Министерство труда, Не требуется занятости и социального развития Республики Ингушетия

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"